통풍, 지금 아플 때부터 평생 관리까지

발작이 왔을 때 무엇을 하고, 요산 약은 언제 시작해 얼마나 오래 먹는지 —
가장 많이 묻는 순서로

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

지금 아플 때 — 먼저 이 네 가지

빨리 알리고 · 관절을 쉬게 하고 · 냉찜질하고 · 드시던 요산 약은 그대로

1

최대한 빨리 알립니다

발작이 시작되면 **빨리** 알려 주세요. 통증을 가라앉히는 **불끄기 약**을 함께 씁니다.

드시던 요산 약에 급성 통증 약을 더하는 것입니다.

시작되면 바로 연락

2

관절을 쉬게 합니다

발작이 오면 다치지 않도록 아픈 관절을 **쉬게** 하세요.

아픈 관절에 무리를 주지 않는 것이 먼저입니다.

아픈 관절은 쉬기

3

찜질은 차갑게 합니다

아픈 부위는 **냉찜질**을 하세요.

핫팩·온찜질은 혈관을 넓혀 염증을 더 키웁니다.

온찜질 대신 냉찜질

4

드시던 요산 약은 그대로

발작이 와도 요산 약은 **그대로** 드세요. 스스로 끊지 않습니다.

끊으면 요산이 출렁여 통증이 오히려 오래갑니다.

스스로 끊지 않기

Tip · 아플 때 잰 요산 수치만으로 통풍이 아니라고 단정할 수 없어, 가라앉은 뒤 다시 잽니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

급성기 약은 세 가지 — 몸 상태를 보고 고릅니다

콩팥·위장·당뇨·심장 상태에 따라 가장 안전한 약을 선택합니다

콜히친 — 저용량으로

고용량과 효과는 비슷하고 부작용은 적습니다. 같이 먹으면 안 되는 약이 있어 복용 중인 약을 **알려 주세요**.

소염진통제

콩팥에 부담을 줄 수 있어 피하는 경우가 많습니다. 위장 출혈·부종·혈압 상승도 주의합니다.

스테로이드

콩팥이 나쁘거나 위장이 약하거나 피 묽게 하는 약을 드실 때 씁니다. 먹는 약·주사 모두 가능합니다. 혈당을 올리므로 **당뇨가 있으면** 미리 알려 주세요.



세 약의 효과는 비슷합니다. 어느 약이 센가가 아니라, 지금 내 몸에 가장 안전한 약으로 정합니다.

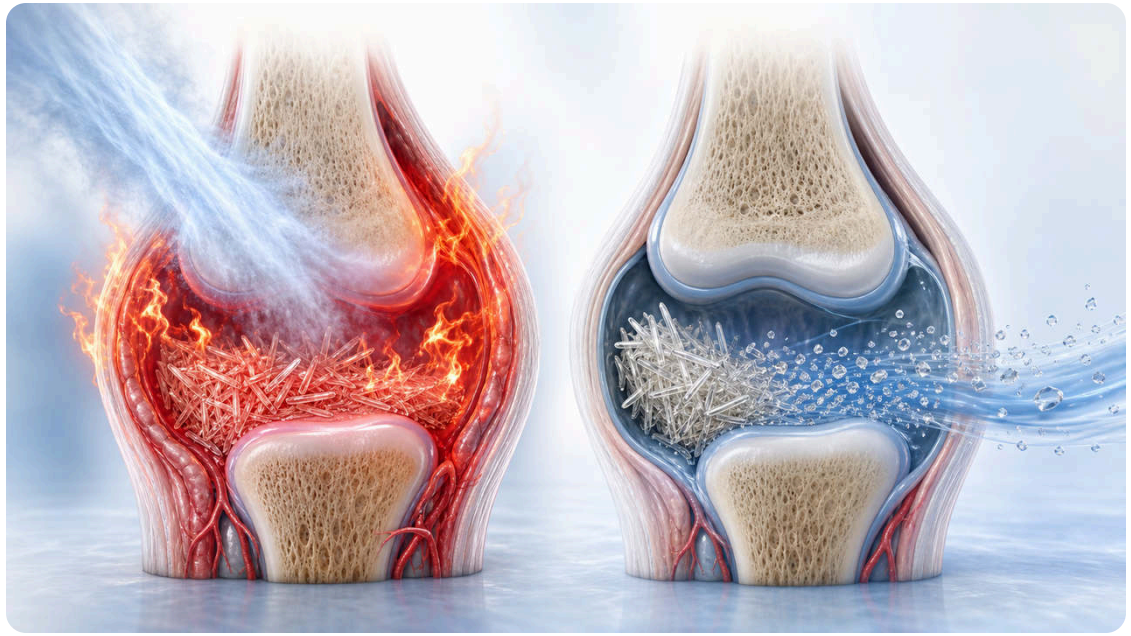
Tip · 두 가지를 함께 쓰면 부작용도 겹칠 수 있어 신중히 정합니다. 셋 다 어려우면 전문의 진료를 권합니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · APLAR 2021 · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

불끄기 약과 청소 약은 다릅니다

통증을 끄는 약과 요산을 치우는 약 — 하는 일이 달라 함께 씁니다



불끄기 약

발작의 통증과 염증을 가라앉힙니다

청소 약(요산 약)

쌓인 요산 결정을 녹여 냅니다

두 약은 하는 일이 다릅니다

통증을 가라앉히는 약과 요산을 녹여내는 약은 **별개**입니다. 발작 때는 두 약을 함께 씁니다.

청소 약은 오래 유지합니다

요산 약은 조건이 맞으면 시작해 **고혈압 약처럼** 오래 드십니다.

발작이 와도 끊지 않습니다

이상반응이 없으면 발작 중에도 그대로 드세요. 끊으면 요산이 출렁여 통증이 오히려 오래갑니다.

Tip · 불끄기 약은 지금의 통증을, 청소 약은 다음 발작을 줄이는 일을 맡습니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016

요산 약 — 누가, 언제 시작하나

조건이 맞으면 시작해 오래 유지합니다 — 경우별로 정리했습니다

경우	이럴 때	어떻게
꼭 시작합니다	통풍결절이 만져질 때 · 뼈 손상이 있을 때 · 발작이 **1년에 두 번 이상**일 때	강하게 권고됩니다
상의해서 정합니다	콩팥병 3기 이상 · 요산 **9 mg/dL** 초과 · 요로결석 · 첫 발작이지만 위험 요인이 겹칠 때	의료진과 함께 정합니다
시작하는 때	발작이 가라앉고 **2~4주 뒤** 시작하는 방법이 널리 쓰입니다	학회마다 권고가 조금씩 다릅니다
증상 없이 요산만 높을 때	대개 약보다 **생활 관리**로 봅니다	요산결석이나 실제 통풍이 있으면 그 이유로 치료합니다

Tip · 요산 약을 시작할지는 수치 하나가 아니라 결절·발작 횟수·콩팥 상태를 함께 보고 정합니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · NICE NG219 2022 · 대한류마티스학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

요산 약 ① — 알로푸리놀과 페북소스타트

알로푸리놀이 1차약입니다 — 낮은 용량으로 시작해 목표까지 천천히 올립니다

알로푸리놀 — 첫 번째 약

요산을 낮추는 1차약입니다. 콩팥 기능이 떨어진 분에게도 1차로 강하게 권고되며, 이때는 시작 용량을 더 낮게 잡습니다.

낮게 시작해 천천히 올립니다

요산이 급하게 떨어지면 오히려 발작이 생기고 과민반응 위험도 올라갑니다. **2~5주** 간격으로 요산을 재며 목표까지 올립니다.

시작 전 유전자 검사

한국인은 시작 전 HLA-B*58:01 유전자 검사를 권합니다. 이 유전자를 가진 비율이 서양인보다 높아, 양성이면 다른 약으로 바꿉니다.

페북소스타트 — 두 번째 약

알로푸리놀이 맞지 않거나 효과가 부족할 때 씁니다. 심장 위험은 연구마다 결과가 달라, 심장병이 있으면 상의해 정합니다.

Tip · 처음부터 높은 용량으로 시작하지 않는 것은 발작과 부작용을 줄이기 위해서입니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · CPIC · 대한류마티스학회

요산 약 ②③ — 배설을 돕는 약, 잘 듣지 않을 때의 약

소변으로 요산을 내보내는 약과, 표준 치료로 목표에 닿지 않는 중증에만 쓰는 주사약

약	어떤 약인가	꼭 확인할 것
벤즈브로마론	소변으로 요산을 내보내는 약으로, 국내에서 실제로 쓸 수 있는 배설 촉진제입니다. 1차약이 맞지 않거나 부족할 때 단독 또는 함께 씁니다.	드물지만 중대한 **간 손상**이 있어 간기능을 정기적으로 봅니다 · 요로결석이 있던 분은 쓰지 않고, 쓸 때는 물을 충분히
페글로티카제	표준 요산 약으로 목표에 닿지 못한 **중증 결절 통풍**에 쓰는 정맥주사약입니다.	국내에는 아직 도입되지 않아 **전문센터 의뢰**가 원칙입니다
라스부리카제	이름이 비슷하지만 **통풍 약이 아닙니다**. 암 치료 중 특수한 상황에만 씁니다.	페글로티카제와 함께, 적혈구 효소(G6PD)가 부족한 분은 쓸 수 없습니다

Tip · 국내 허가·급여 현황은 처방 시점에 다시 확인합니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약 부작용은 '느껴지는 신호'로 기억하세요

아래 신호가 있으면 약을 멈추고 바로 오세요 — 혼자 참지 마세요

알로푸리놀 · 페북소스타트

원인 모를 열, 피부 발진, 입안 짓무름, 눈 충혈, 얼굴 부종 — **즉시 중단**하고 오세요.

콜히친

멈추지 않는 심한 설사, 쥐가 나는 듯한 복통, 근육 통증은 **독성 신호**입니다.

소염진통제 · 스테로이드

검은 변·토혈, 소변량이 갑자기 줄고 붓는 것, 열과 함께 온몸이 쳐지는 느낌.



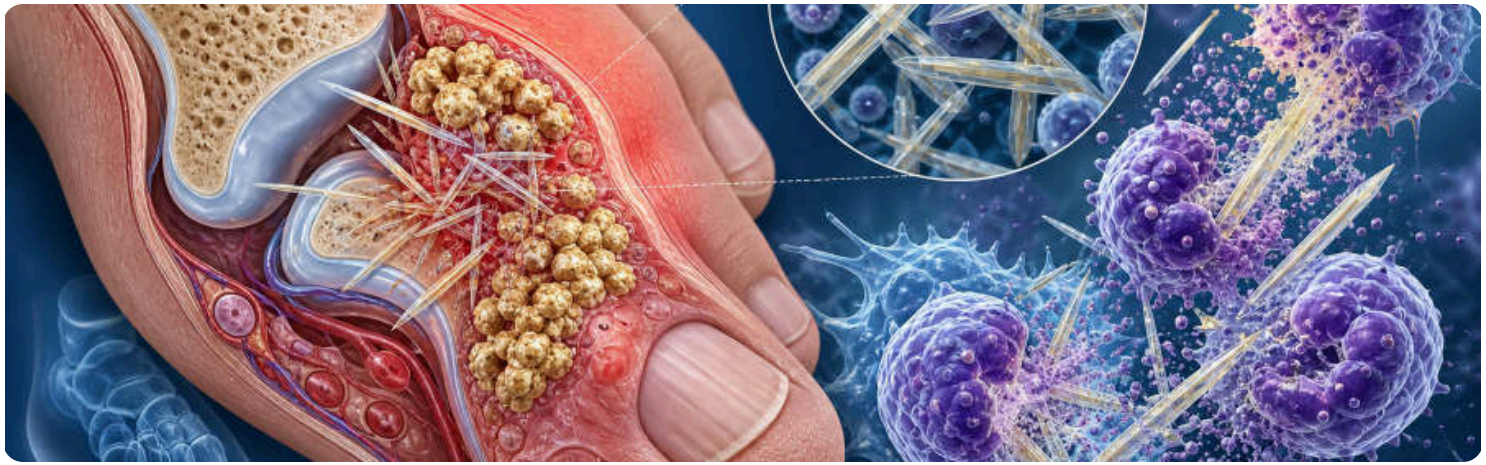
유전자 검사가 음성이어도 위험이 완전히 없지는 않아, 시작 초기에 발진을 함께 지켜봅니다.

Tip · 알려 주시면 용량을 조절하거나 약을 바꿉니다. 정해진 날짜에 꾸준히 재진받으세요.

근거 · ACR 2020 · CPIC · 대한류마티스학회

요산 약을 시작하면 처음엔 발작이 늘 수 있습니다

실패가 아니라 예정된 과정 — 그래서 '발작을 막는 약'을 같이 씁니다



3~6개월

요산 약을 시작하거나 올릴 때, 발작을 막는 약(저용량 콜히친 또는 저용량 소염진통제)을 함께 쓰는 최소 기간

⚠ 왜 같이 쓰나

요산이 초기에 급하게 내려가면 오히려 발작이 생길 수 있어, 낮은 용량부터 시작하고 예방약을 처음부터 같이 씁니다.

언제 멈추나

결절이 있거나 발작이 이어지면 더 늘립니다. 목표 수치에 닿고 발작이 없으면 **예방약만** 멈춥니다.

Tip · 굶거나 극단적인 저탄수화물·고지방 식사는 오히려 발작을 부릅니다. 체중은 천천히 줄이세요.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

콩팥·심장이 안 좋으면 무엇이 달라지나

약을 못 쓰는 것이 아니라, 고르는 약과 시작 용량이 달라집니다

이럴 때	이렇게 달라집니다
콩팥이 안 좋을 때 · 발작	소염진통제 대신 **스테로이드** 소염진통제는 콩팥에 부담을 줄 수 있어 피하는 경우가 많고, 스테로이드를 먹는 약·주사로 씁니다
콩팥이 안 좋을 때 · 요산 약	알로푸리놀은 그대로 **1차약** 시작 용량만 더 낮추고, 요산을 재면서 올립니다
심장병이 있을 때	**알로푸리놀**을 먼저 고려 페북소스타트는 심장병이 있는 분에서 위험이 논쟁 중입니다
스스로 끊고 싶을 때	끊기 전에 **먼저 상의** 임의로 끊으면 오히려 위험이 커질 수 있다는 자료가 있습니다
증상 없이 요산만 높을 때	대개 **약을 쓰지 않습니다** 요산 약이 콩팥병 진행을 늦춘다는 근거가 부족합니다

Tip · 특히 조심할 분 — 고령, 콩팥병·심부전, 피 묽게 하는 약 복용, 위장관 출혈을 겪은 적이 있는 경우.

근거 · ACR 2020 · KDIGO · EULAR 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

식사 — 무엇을 줄이고, 무엇은 그대로 드셔도 되나

동물성 퓨린과 술·단 음료는 줄이고, 콩·두부·버섯 같은 식물성 퓨린은 제한하지 않습니다

그대로 드셔도 되는 것

- **콩·두부·버섯·시금치**
  식물성 퓨린은 발작을 늘리지 않습니다
- **저지방 우유·요구르트**
  오히려 도움이 됩니다
- **커피**
  위험을 낮춘다는 연구가 있습니다
- **살코기 위주로 적정량**
  완전히 끊지 마세요
- **등푸른생선·해산물**
  적당한 양으로
- **천천히 체중 감량**
  굶는 다이어트는 금물

VS

줄여야 하는 것

- **맥주**
  술 중에서 위험이 가장 큽니다
- **소주·양주**
  독주도 요산과 발작을 늘립니다
- **와인**
  위험은 낮지만 총량을 줄이세요
- **콜라·주스·에너지드링크**
  단 음료를 줄이세요
- **곱창·간 등 내장류**
  진하게 우린 곰탕 국물도 줄이세요
- **체리·비타민 C 보충제로 약 대신하기**
  근거가 약합니다

Tip · 식사 조절은 약을 대신하지 않습니다 — 요산 약과 함께 갑니다.

근거 · 대규모 코호트·메타분석 · ACR 2020

목표 수치와 기간, 그리고 바로 오셔야 하는 때

목표에 닿아도 약은 계속 유지합니다 — 콩팥·간기능도 함께 봅니다



6 mg/dL 미만

일반적인 목표 — 국내 지침도 같은 기준입니다

5 mg/dL 미만

통풍결절이 있거나 중증이면 더 낮게 두기도 합니다

2~5 주

시작·증량 중 검사 간격 — 안정되면 6개월쯤마다

얼마나 오래 먹나

목표에 닿아도 대개 **오래** 드십니다. 결정은 서서히 녹아, 일찍 끊으면 다시 쌓입니다.

임의로 끊으면

요산이 급격히 변해 관절에 쌓인 결정이 흔들리고 통증이 훨씬 오래갑니다. 상의해 정합니다.

바로 오셔야 하는 때

열이 나며 여러 관절이 한꺼번에 아프거나, 한 관절이 갑자기 심해지고 온몸이 쳐질 때.

그림 · 요산 재기 → 결정 녹이기 → 꾸준히 복용 → 정기 검사 → 관절 지키기.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · NICE NG219 2022 · 대한류마티스학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

불끄기 약으로 통증을 잡고, 청소 약으로 요산을 낮춥니다

목표는 6 mg/dL 미만 — 꾸준히 유지하면 결절과 발작을 줄일 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

통풍으로 치료 중인 분을 위한 설명자료입니다. 약의 선택과 용량은 담당 의사와 정하고, 발작 때 할 일은 통풍 안내문에 정리했습니다.

참고한 자료

미국류마티스학회(ACR) 2020 · 유럽류마티스학회(EULAR) 2016 · 대한류마티스학회 2022 · 영국 NICE NG219 2022 · 아시아태평양류마티스학회(APLAR) 2021 · CPIC 유전자 지침 · KDIGO

다시 보기 · 카톡 공유